

Dieta 50/50 po 50-tce: czy post co drugi dzień działa lepiej?



Szybka odpowiedź

Dieta 50/50, rozumiana jako post naprzemienny, może zmniejszać masę, jeśli obniża średnią podaż energii. W rocznym badaniu 100 dorosłych nie dawała większego spadku masy niż codzienne ograniczenie kalorii, a grupa postu częściej rezygnowała. Po 50-tce najważniejsze są bezpieczeństwo leków, utrzymanie białka i wybór schematu, który można kontynuować.

Kluczowe wnioski

- Post naprzemienny jest sposobem organizacji deficytu energii, nie osobnym mechanizmem spalania tłuszczu.
- Roczne RCT nie wykazało przewagi utraty masy nad codziennym ograniczeniem energii.
- Badani mieli średnio 44 lata, więc wyniku nie wolno przedstawiać jako próby wyłącznie u osób po 50-tce.
- Insulina, pochodne sulfonilomocznika, niedowaga i historia zaburzeń odżywiania wymagają szczególnej ostrożności.

Na czym polega dieta 50/50?

W tym artykule 50/50 oznacza alternate-day fasting: naprzemienne dni bardzo małej podaży energii i dni jedzenia bez wyznaczonego deficytu. Nazwa nie jest standardem klinicznym, dlatego zawsze trzeba doprecyzować harmonogram, kalorie w dni postne i zasady dni zwykłych.



W tym artykule 50/50 oznacza alternate-day fasting: naprzemienne dni bardzo małej podaży energii i dni jedzenia bez wyznaczonego deficytu.

Jeśli w dni jedzenia pojawia się kompensacyjne przejadanie, średni deficyt może zniknąć. Schemat nie zwalnia też z dbania o białko, warzywa i jakość produktów. Fundamenty omawia [poradnik diety po 50-tce](#).

Co wykazało roczne badanie porównawcze?

Randomizowane badanie objęło 100 dorosłych z otyłością, ze średnim wiekiem około 44 lat. Po 12 miesiącach zmiana masy wynosiła około $-6,0\%$ w grupie postu naprzemiennego i $-5,3\%$ przy codziennym ograniczeniu energii. Różnica między strategiami nie była istotna statystycznie.



Randomizowane badanie objęło 100 dorosłych z otyłością, ze średnim wiekiem około 44 lat.

Z grupy postu zrezygnowało 38% uczestników, z codziennego ograniczenia 29%, a z kontroli 26%. To ważny wynik praktyczny: skuteczność planu obejmuje również możliwość jego utrzymania. Nie należy z tego badania obiecywać osobom po 50-tce konkretnej utraty kilogramów.

Czy post daje dodatkową przewagę metaboliczną?

Duża metaanaliza sieciowa 99 badań wykazała niewielką przewagę postu naprzemiennego nad ciągłym ograniczeniem masy ciała, około 1,29 kg. Autorzy wskazali, że jest to poniżej przyjętego przez nich progu 2 kg dla istotności klinicznej, a w dłuższych badaniach przewaga nie była jasna.



Duża metaanaliza sieciowa 99 badań wykazała niewielką przewagę postu naprzemiennego nad ciągłym ograniczeniem masy ciała, około 1,29 kg.

Poprawa glikemii i lipidów zwykle współwystępuje ze zmianą masy i energii. Nie ma podstaw, by mówić o „resecie metabolizmu” albo detoksie. O realnych determinantach wyniku przeczytasz w [artykule o spalaniu tłuszczu](#).

Jak chronić mięśnie podczas redukcji?

Dni bardzo małej podaży energii utrudniają rozłożenie białka w posiłkach. Po 50-tce trzeba równolegle zaplanować trening oporowy, wystarczającą ilość białka i umiarkowane tempo redukcji. Sam spadek masy nie mówi, jaka część pochodzi z tkanki tłuszczowej.



Dni bardzo małej podaży energii utrudniają rozłożenie białka w posiłkach.

Jeśli post pogarsza trening, sen albo powoduje napady jedzenia, codzienny łagodny deficyt może być lepszym narzędziem. Cel białka można oszacować w [kalkulatorze białka](#), z korektą w chorobach wymagających indywidualizacji.

Kto nie powinien zaczynać bez konsultacji?

Post może prowadzić do niedocukrzenia u osób przyjmujących insulinę lub niektóre leki przeciwcukrzycowe, jeśli dawki nie zostaną skorygowane. Ostrożność jest konieczna przy niedowadze, niedożywieniu, chorobie nerek, częstych omdleniach oraz historii zaburzeń odżywiania.



Post może prowadzić do niedocukrzenia u osób przyjmujących insulinę lub niektóre leki przeciwcukrzycowe, jeśli dawki nie zostaną skorygowane.

Nie odstawiaj i nie przesuwaj leków na własną rękę, aby dopasować je do internetowego jadłospisu. Zawroty głowy, splątanie, omdlenie i objawy hipoglikemii wymagają przerwania postu i działania zgodnie z planem medycznym. Bezpieczniejszy start opisuje [plan powrotu do formy](#).

Post 50/50 a codzienny deficyt — wynik rocznego RCT

Cecha	Post naprzemienny	Codziennie ograniczenie
Zmiana masy po 12 miesiącach	Okolo -6,0%	Okolo -5,3%
Rezygnacja z grupy	38%	29%
Przewaga jednej strategii	Brak istotnej różnicy masy	Brak istotnej różnicy masy
Najważniejszy wybór	Czy harmonogram jest wykonalny	Czy codzienny limit jest wykonalny

Najczęściej zadawane pytania

Czy dieta 50/50 jest lepsza od zwykłego deficytu?

W rocznym RCT nie spowodowała istotnie większej utraty masy niż codzienne ograniczenie energii.

Czy w dni niepostne można jeść bez ograniczeń?

Brak wyznaczonego limitu nie znosi bilansu energii; kompensacyjne przejadanie może zmniejszyć lub wyzerować deficyt.

Czy post 50/50 jest przebadany po 50-tce?

Najważniejsze roczne RCT miało średni wiek około 44 lat, więc nie jest badaniem wyłącznie osób po 50-tce.

Czy można pościć przy cukrzycy?

Przy insulinie lub lekach grożących niedocukrzeniem post wymaga uzgodnienia leczenia z lekarzem.

Chcesz uporządkować LDL, ApoB, trójglicerydy i plan badań? Zobacz [Centrum Cholesterolu i Badań po 50-tce](#).

Źródła

1. [Trepanowski i wsp. — alternate-day fasting randomized trial](#)
2. [BMJ — intermittent fasting strategies, systematic review and network meta-analysis](#)
3. [ESPEN Expert Group — protein intake and exercise for ageing muscle](#)
4. [WHO — Healthy diet](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.